

ΕΠΙΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Γενικά: Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ/ΗΦ) εκδηλώνεται ως μια χρόνια κλινική κατάσταση, κατά την οποία ο ασθενής εμφανίζει τυπικά σημεία και συμπτώματα τα οποία επηρεάζουν άμεσα και σε μεγάλο βαθμό την υγεία, την καθημερινότητα και το προσδόκιμο ζωής του.

Η διάγνωση της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας (ΧΚΑ) βασίζεται ακριβώς σε αυτά τα κλινικά σημεία και συμπτώματα, στην **εργαστηριακή διερεύνηση** (*I/A, Glu, HbA1c, Urea, Creat., K^+/Na^+ , BNP/pro-BNP*) και στην **υπερηχοκαρδιογραφία** (echo ή triplex καρδιάς).

Τα κλινικά κριτήρια Framingham βοηθούν στη διάγνωση, με χαμηλή όμως ειδικότητα. Περιλαμβάνουν μείζονα και ελάσσονα κριτήρια, έτσι ώστε η διάγνωση της ΧΚΑ να απαιτεί δύο (2) μείζονα κριτήρια ή ένα μείζον και δύο ελάσσονα (1+2) κριτήρια.

Τα κύρια (μείζονα) κριτήρια περιλαμβάνουν τα εξής:

- | | |
|--|--|
| • <i>ορθόπνοια,</i> | • <i>αυξημένη σφαγιτιδική φλεβική πίεση,</i> |
| • <i>πνευμονικοί τρίζοντες</i> | • <i>παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια,</i> |
| • <i>S₃ καρδιακός τόνος,</i> | • <i>απώλεια βάρους > 4,5 kg, σε 5 ημέρες, ως</i> |
| • <i>καρδιομεγαλία στην α/α θώρακος,</i> | • <i>απόκριση στη θεραπεία υποτιθέμενης ΚΑ.</i> |
| • <i>πνευμονική συμφόρηση στην α/α θώρακα,</i> | |

Τα δευτερεύοντα (ελάσσονα) κριτήρια περιλαμβάνουν τα εξής:

- | | |
|--------------------------------|--|
| ▪ <i>νυχτερινός βήχας,</i> | ▪ <i>ταχυκαρδία (HR > 120 bpm),</i> |
| ▪ <i>δύσπνοια προσπαθείας,</i> | ▪ <i>αμφοτερόπλευρο οίδημα στα πόδια,</i> |
| ▪ <i>υπεζωκοτική συλλογή,</i> | ▪ <i>απώλεια βάρους < 4,5 κιλά σε 5 ημέρες.</i> |
| ▪ <i>ηπατομεγαλία,</i> | |

Η επίταση της ΧΚΑ εμφανίζεται αρκετά συχνότερα σε ασθενείς ηλικίας > 75 ετών, με σοβαρού βαθμού νόσο, που διαβιώνουν μόνοι, σε δυσπρόσιτες περιοχές με δυσχερή πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και με ελλιπή κατανόηση ή συμμόρφωση στις ιατρικές οδηγίες.

Δραματικότερη κλινική έκφανση της ΧΚΑ αποτελεί η ακραία και οξεία εκδήλωσή της, δηλαδή το Οξύ Πνευμονικό Οίδημα (ΟΠΟ) και το καρδιογενές shock.

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής πιθανώς να παραπονείται για συνεχώς επιδεινούμενη δύσπνοια από αρκετές ημέρες, ήπιο βήχα, έχει όψη πάσχοντος, ενίοτε έχει καταβολή, υπνηλία ή ζάλη, καθώς και ψυχρά άκρα. Αναφέρεται πιθανώς επίταση των οιδημάτων στα κάτω άκρα, στην οσφύ ή τα βλέφαρα. Μπορεί επίσης να αναφέρει τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής, με δική του πρωτοβουλία, για ποικίλους λόγους, η οποία απορρύθμισε τη ΧΚΑ.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχουμε τη δοσολογία και τον τρόπο λήψεως φαρμάκων, ενώ αναζητούνται τα πιθανά αίτια (*π.χ. παρενέργεια φαρμάκου, νέα ιατρική οδηγία, προσθήκη φαρμάκου, κ.λπ.*) που οδήγησαν τον ασθενή σε τροποποίηση, ίσως, της φαρμακευτικής αγωγής για τη ΧΚΑ. Ελέγχουμε για παράγοντες συννοσηρότητας (*λοιμωξη, παρόξυνση ΧΑΠ, ΣΝ, ΣΔ, κ.ά.*).
2. Μετράμε ζωτικά σημεία (*BP/HR/RR/S_pO₂*). Αξιολογούμε το ΗΚΓ και την κλινική εικόνα.
3. Χορηγούμε O₂ (*4-8 lt/min*), με απλή προσωπίδα ή με μάσκα Venturi, ώστε S_pO₂ > 94%.
4. Τοποθετούμε φλεβική γραμμή και χορηγούμε 1-3 amp. Lasix εντός 100-250 ml N/S ή D₅W· (*Σημ: η συνεχής στάγδην έγχυση της Φουροσεμίδης έχει αποδειχθεί ότι είναι σαφώς πιο αποτελεσματική από την iv-bolus χορήγηση, ενώ μειώνει την ωτοτοξική δράση της*).
5. Ο ασθενής μπορεί να παραμείνει για 30-120 λεπτά στο ιατρείο, στο ΤΕΠ ή στη MBN, για παρακολούθηση και διόρθωση όποιας άλλης συνοδού κατάστασης (*ΑΥ, αρρυθμία, ισχαιμία, δύσπνοια κ.ά.*) και μπορεί αργότερα να αποχωρήσει για το σπίτι του με οδηγίες.
6. Ίσως χρειαστεί να τροποποιήσουμε τη φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς για την ΧΚΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, διατηρούμε τακτική επαφή με τον ασθενή, ενώ πιθανότατα να χρειαστεί παραπομπή σε καρδιολογικό ιατρείο για περαιτέρω διερεύνηση και θεραπεία.